

Fecha Última Actualización: 29-06-2022 19:14:25

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Delia Ramirez Gutierrez
Edad : 61a 6m 18d
Dirección : Rio Angostura 577

Rut : 8.900.684-8
Fecha Nacto: 11/12/1960
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2209009
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 6693 7932

N° Epicrisis
310358

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 08/05/2022 02:00

Días Estadía: 52

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 29/06/2022 19:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICIRIS DEFINITIVA 29/6/22

DELIA RAMIREZ GUTIERREZ

RUT: 8.900.684-8

EDAD: 61 años

Peso: 75 Kg Talla: 1.55 m

FI CASR: 08/05/22

FI UTIM: 10/05/22

FI UPC: 26/05/22

FRI UCI: 15/06/22

Días VMI: 26/05 - 30/05, reintubación 30/05 - 05/06. reintubación 14/06 - autoextubación 16/06

ANTECEDENTES

Médicos: DM2 NIR con daño de órgano blanco (Retinopatía proliferativa, Pie diabético (izquierdo), HTA, Falla renal crónica en estudio (obs. Nefropatía diabética), Obesidad, Arritmia en estudio / FA paroxística, Cardiopatía coronaria, enfermedad coronaria severa de dos vasos (90% 1/3 medio DA (PCI / DES 23/05) / CD proximal 70% pendiente)

Fármacos: Valsartán 160mg 9:00am y 9:00pm, Hidroclorotiazida 25 mg 8:00am, Amlodipino 10 mg 9:00am

Alergias: (-)

Hábitos: OH (-) TBQ (-) Drogas (-)

Inmunizaciones: Esquema de vacunación completo para SARS COV

HISTORIA DE INGRESO

Paciente con antecedentes descritos, es derivada al servicio de emergencia de esta institución el 08/05/2022 desde atención primaria en salud por cuadro clínico caracterizado por dolor epigástrico 7/10 irradiado hacia región precordial, FA de alta respuesta ventricular, EKG con IDST en DI - DII - V2 - V6 e hipertensión arterial.

A su ingreso al servicio de urgencias, se presenta taquicárdica, normotensa, al interrogatorio dirigido refiere oliguria de 16 semanas de evolución, control de EKG sin supradesnivel de ST, se realiza pielotc que revela lesión de aspecto lipomatoso suprarrenal izquierda, un origen sarcomatoso no se puede descartar y lesión masiforme anexial derecha, no caracterizable en este estudio. Leve derrame pleural derecho.

Fecha Epicrisis : 29/06/2022 19:14

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 29-06-2022 19:14:25

Página 2 de 4

Se hospitaliza, evoluciona con anemia y se pesquisa hematoma de psoas sin causa aparente; requiere soporte transfusional; suma progresión de falla renal por lo que requiere hemodiálisis, durante el procedimiento presenta paro cardiorespiratorio que requiere reanimación cardiovascular avanzada por 1 ciclo revirtiendo a circulación espontánea, se intuba y se traslada a UCI el 26/05/2022.

En UCI es evaluada por cardiología que descartan por el momento necesidad de coronariografía urgente.

PRIMERA ESTADÍA EN UCI

Motivo de ingreso

- PCR recuperado de causa en estudio, impresiona infarto tipo 2 en paciente con anemia / hipovolemia en contexto de resangrado (hematoma del psoas) y aumento de demanda: PCR durante la diálisis.
- Falla renal crónica reagudizada

Intercurrencias en UCI

- Fallo de extubación 30/05/2022 ¿ re intubación
- Sepsis intrahospitalaria 30/05/2022
 - S. epidermidis / S. Haemolyticus en punta de CVC / Infección asociada a catéter de hemodiálisis. ¿ VANCO ajustada a función renal.
 - Neumonía asociada a ventilación mecánica por A. Baumannii y SAMS ¿ Sensible a AMPI SUL.

A su ingreso en UCI, requirió soporte transfusional en contexto de anemia que se interpretó secundaria a hemorragia por resangrado del psoas (imagen de pelvis que reveló aumento de volumen de hematoma del psoas previamente conocido), vasoactivos y sedación profunda, presentó mejoría hemodinámica y se inició despertar el 29/05/2022 y se extubó el 30/05/2022, intercurrió con falla de extubación por paresia de músculos respiratorios, requirió reintubación el mismo 30/05/2022, además evolucionó febril y con aumento de parámetros inflamatorios, requirió cultivos, cambio de CVC y antibiótico de amplio espectro, de los cultivos se rescató: infección asociada a CVC por S. epidermidis y S. haemolyticus al momento en tratamiento con VANCO y neumonía asociada a VMI por A. Baumannii en tratamiento con AMPI SUL, con buena respuesta clínica y gasométrica.

Se extubó con éxito el 05/06/2022, con apoyo con cánula de alto flujo y luego oxígeno suplementario hasta el momento con buena tolerancia, sin mayor conflicto de intercambio gaseoso.

Requiere hemodiálisis aguda, en la fecha se dializó sin interurrencias.

Al examen físico se presenta vigil, Glasgow 15/15, pupilas isocóricas, reactivas, ventilando espontáneamente con apoyo de oxígeno suplementario, a la auscultación sin ruidos sobreagregados a la auscultación pulmonar, abdomen blando, depresible, RHA presentes, extremidades simétricas.

Egresó de UCI en buenas condiciones generales el 08/06/2022 a UTIM

EVOLUCIÓN EN UTI

Intercurrencias en UTIM

- Shock hipovolémico 09/06/2022
 - Soporte transfusional
- Paro cardiorrespiratorio 13/06/2022
- FA de alta respuesta ventricular

El 09/06/2022 intercorre con shock hipovolémico, requiere soporte transfusional que logra rápida estabilización y suspensión de drogas vasoactivas, TC realizada el 12/06/2022 demuestra estabilidad del hematoma del psoas y del hematoma intraperitoneal, no queda claro el origen del sangrado.

Se suspendió VANCO considerando que S. epidermidis y S. haemolyticus no tenían rol patológico.

Requiere hemodiálisis aguda durante su estadía en UTIM, describen sobrecarga de volumen, con regular tolerancia, requiere apoyo ocasional con VMNI y vasoactivos en títulos bajos. Intercurrió con episodios de FA de alta respuesta ventricular con requerimiento de amiodarona.

El 13/06/2022 a las 20:32 evolución de enfermería describe paciente lúcida, bien perfundida, saturando 97% con FiO2 ambiental, buena mecánica ventilatoria. A las 21:05 se describe en malas condiciones generales, compromiso de conciencia,

Fecha Epicrisis : 29/06/2022 19:14

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 29-06-2022 19:14:25

Página 3 de 4

bradicárdica e hipotensa, requiere 1 mg de atropina, evoluciona a PCR (presenciado), inicia RCP avanzado, 1 ciclo, 1 mg de adrenalina, se intuba y se conecta a ventilación mecánica, retorna a circulación espontánea, requiere noradrenalina en títulos bajos que se logra titular a la baja hasta suspender.

Evolución médica del 14/06/2022 describe PCR recuperado posterior a bradicardia extrema, obs. Secundaria a fármacos (amiodarona)

SEGUNDA ESTADÍA EN UCI

Ingresa sedoanalgesiada hasta RASS -2, con MIDA y FENTA, pupilas mióticas, reactivas, isocóricas, intubada, se conecta a ventilación mecánica invasiva, en presión de control, P 10 PEEP 5, FR 22, Ti 0.80, FiO2 25%, DP 10, buena entrada de aire bilateral, sin ruidos sobreagregados a la auscultación, R1 y R2 normo fonéticos, FC 80 latidos por minuto, abdomen blando, depresible, RHA disminuidos, extremidades simétricas, llenado capilar 2 segundos.

Diagnósticos de ingreso

- PCR recuperado; en contexto de bradicardia (Obs. Secundaria a fármacos)
- Intubación orotraqueal, ventilación mecánica invasiva, sedación profunda.

Evolución en UCI

Hemodinámico: Ingresa sin DVA, se mantiene con hemodinamia autosostenida durante estadía sin caída de Hb/hcto, sin exteriorización de sangrados. Presenta episodio de FA con RVR durante HD el día 15/06 con hemodinamia estable. Se mantiene con BIC de amiodarona la cual se logra suspender. Destaco el día 28/6 presenta caída de hemodinamia con inicio de drogas vasoactivas destacando Nad hasta 0.4 ug/kg/min. Durante la noche 28/6 presenta episodio de rectorragia, con alza de requerimientos de NAD hasta 1 ug/kg/min. Se solicitan 2 U GR, se suspenden tromboprofilaxis y nutrición enteral. Evoluciona en malas condiciones generales con Nad hasta 1.5 ug/kg/min a Adrenalina 0.5 ug/kg/min a pesar de volemicación y transfusión.

SNC: A su ingreso con sedo analgesia con fentanil y midazolam los cuales se suspenden precozmente, iniciando Propofol. Se logra suspender la sedación el día 15/06, logrando vigilia espontánea. Inicialmente cursa con agitación, autoextubándose el 16/06 en la madrugada, requiriendo risperidona logrando manejo de agitación. Actualmente sin agitación, persiste con delirium, más conectada, orientada en espacio. Potenciar medidas no farmacológicas de delirium.

Respiratorio: Ha requerido VMI en 2 oportunidades por paros cardiorrespiratorios, 26/05 - 05/06 (con extubación fallida el 30/05), 14 - 16/06 (autoextubación) y en 3° ocasión por falla respiratoria, agitación y mal control de secreciones desde el 20/06. Con evolución favorable en lo ventilatorio, FiO2 al 21%, PAFIs >200, sin embargo con irre g u lar control de secreciones.

Renal: : Ingresa por síndrome urémico, con extenso estudio negativo, a destacar proteinuria 24 g/día, riñones de tamaño normal, AngioTAC con estenosis 50% arteria renal derecha, 60% izquierda, SOC con hematuria dismórfica, VHS 78, FO con retinopatía diabética proliferativa, complemento bajo, ANA (-), ANCA (-), antiDNA (-), IgG levemente alta, Ig A y M normales, anticuerpos anti MBG (-), EFP pendiente hace 1 mes. Impresiona nefropatía diabética, con requerimiento de TRR, oligoanúrica con última HD 27/06.

Infeccioso: Paciente ingresa con diagnóstico de NAVM por A. baumannii y SAMS sensibles a ampicilina/sulbactam, se indica tratamiento por 14 días completándolo el día 16/06. En cultivos anteriores, presentó hemocultivo 1 positivo para SAMS y cultivo de CVC de HD positivo para S. epidermidis + haemolyticus (31/05) se interpreta como contaminación por lo que se suspendió vancomicina (5 días de terapia). En HC de control (09/06) negativos, cultivos CVC por arrastre negativos y eco TT negativo para vegetaciones.

En UTI se había solicitado RM de pie para descartar osteomielitis, pero no impresiona cuadro compatible, de todas maneras se solicita reevaluación por cirugía vascular para definir conducta quirúrgica.

Múltiples intercurencias, inicialmente ITU manejada empíricamente con Ceftriaxona. 29/05 NAVM bacterémica por SAMS, además de NAVM por ACBA, tratada con ampicilina sulbactam 14 días. Último hit documentado el 20/06, con KPN en CAET y UC, se mantiene en tratamiento con Imipenem. Destaca cuadro febril 27/06, por lo que se recultivó y se rotó CHD, agregando Vancomicina, en dosis ajustada con equipo de farmacología.

Profilaxis: Habituales con HNF en contexto de falla renal e IBP. Suspendida dentro de contexto de rectorrgia.

Paciente evoluciona en graves condiciones generales con requerimiento de Nad y Adrenalina en dosis altas. Conversado con jefe de modulo, se explica a familia situacion y se decide manejo de fin de vida acompañado de familiares. Acuden familiares

Fecha Epicrisis : 29/06/2022 19:14

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 29-06-2022 19:14:25

Página 4 de 4

en ultimos momentos de vida, falleciendo junto a ellos a las 18:20 hrs.
Se entrega certificado de defuncion.

Diagnóstico de Egreso

CHOQUE HIPOVOLEMICO - 2 Paros cardiorrespiratorios recuperados
- 26/05 2° IAM tipo 2 en contexto de FA RVR
- 15/06 farmacológico (sospecha: amiodarona y haloperidol)
Shock hemorrágico
- Rectorragia 29/06
Insuficiencia renal aguda vs crónica en TRR: Sospecha de nefropatía diabética
- Proteinuria nefrótica
Sepsis foco urinario y pulmonar por KPN BLEE
Múltiples FA RVR
Delirium hiperactivo
Miopatía del paciente crítico
IAM SSDST tratado -> PCI ADA 23/05 + lesión 70% ACD
UPP sacra III
Hematoma de iliopsoas derecho
Lesión anexial derecha en estudio
Pie diabético, necrosis seca
Neumonía bacterémica por SAMS y NAVM por ACBA tratadas
Antecedentes: HTA, DM2 NIR, obesidad.

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIDO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Maria Gabriela Bofill Brito

Becado/Residente

Maria Paz Piñeiro Perez

Médico Tratante (Staff)

INTERNO

Fecha Epicrisis : 29/06/2022 19:14

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:35

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar